

Material de supervisión

Sesión N° 1, [fecha xx/xx/xxxx]

Sesión inicial con una mujer que consulta por bloqueo para reincorporarse al mercado laboral tras diez años dedicada a la crianza. El encuentro tuvo una textura activa y técnicamente coherente: el terapeuta condujo con claridad desde un modelo de defusión cognitiva, logró anclar la intervención en un ejercicio concreto dentro de la misma sesión, y cerró con una tarea definida. La paciente mostró engagement genuino y cierre emocional visible.

Momento 1 — Mapeo del sistema de pensamientos y construcción de la metáfora

La paciente llegó con un discurso acelerado, caótico y autorreferencial: múltiples pensamientos negativos sobre su capacidad, su edad y la mirada del mercado laboral circulaban sin jerarquía ni punto de entrada. El patrón observable era pensamiento en cascada que produce parálisis conductual: cuanto más intenta movilizarse, más se activa el circuito rumiativo.

El terapeuta intervino proponiendo la metáfora del equipo de fútbol para organizar ese sistema: un "capitán" (no soy suficiente), un "entrenador" (voy a fracasar), y jugadores secundarios. La función de esta intervención fue doble: crear distancia observacional respecto al contenido de los pensamientos, y ofrecer un mapa compartido que pudiera sostenerse a lo largo de la sesión y las siguientes.

La paciente respondió con fluidez, identificó los elementos con facilidad y los relató con cierta distancia afectiva inicial. Esto es consistente con el objetivo de la metáfora, aunque no es evidencia de cambio conductual todavía.

Nota: La metáfora fue construida de modo colaborativo y resultó funcional en sesión. Queda abierto si la paciente podrá activarla autónomamente fuera del consultorio, o si requiere andamiaje adicional para internalizarla.

Momento 2 — Ejercicio de defusión en vivo: escritura y observación del pensamiento

El problema que motivó esta intervención era inmediato y visible: la paciente activó en tiempo real el mismo patrón de rumiación que describía (calor en el cuerpo, salto de pensamiento en pensamiento, bloqueo). El terapeuta aprovechó ese momento para introducir un ejercicio de defusión: escribir el pensamiento en un papel, contarle palabras, vocales, observar su tipografía.

El diseño es coherente con ACT aplicado estratégicamente: interrumpir la fusión cognitiva mediante la distancia perceptual. Lo que resultó significativo fue que el terapeuta no solo explicó el principio sino que lo aplicó en vivo, dentro de la sesión, generando una experiencia

directa. La paciente pudo nombrar que habitualmente "salta al siguiente pensamiento" y reconoció que ese salto es el inicio de la cascada paralizante.

La reacción fue de curiosidad y participación activa. La intervención produjo el efecto buscado en ese contexto específico.

Nota a supervisión: La técnica fue aplicada una sola vez, en condiciones óptimas (presencia del terapeuta, encuadre seguro). La tarea asignada replica ese ejercicio de modo autónomo. Vale la pena preguntarse: ¿se le dio a la paciente suficiente práctica dentro de sesión antes de pedirle que lo haga sola? Si la tarea no se cumple, ¿cuál sería el riesgo de que una nueva indicación similar reproduzca, desde el lado del terapeuta, la lógica de "más de lo mismo"?

Momento 3 — Proyección a futuro y asignación de tarea

El terapeuta usó una proyección de consecuencias negativas (¿cómo estarías dentro de un año si seguís igual?) para activar motivación y valores, con resultado claro: la paciente se conmovió al imaginar el impacto en sus hijos y su pareja. Desde ese lugar movilizado, se acordó una tarea concreta: actualizar el currículum mañana a la tarde, con la instrucción de escribir los pensamientos que aparezcan y observarlos en lugar de seguirlos.

La tarea está bien delimitada en tiempo, acción y procedimiento. La paciente verbalizó el plan con sus propias palabras, lo que es buen indicador de apropiación.

Preguntas para llevar a supervisión

1. La tarea requiere que la paciente aplique sola, por primera vez, una habilidad que practicó una sola vez en sesión. Si no la cumple —o la cumple parcialmente—, ¿cómo se diseña la siguiente intervención sin caer en repetir la misma prescripción con más énfasis?
2. El circuito de rumiación parece tener también una dimensión relacional no explorada aún: la paciente mencionó rencor hacia su marido y la sensación de "ser la que renuncia a todo". ¿Vale la pena abrir esa línea en las próximas sesiones, o hacerlo prematuramente complejiza un proceso que acaba de iniciarse con foco claro? (Nota: lo dicho sobre el marido proviene exclusivamente del relato de la paciente; es una hipótesis tentativa, no un dato verificado del sistema.)